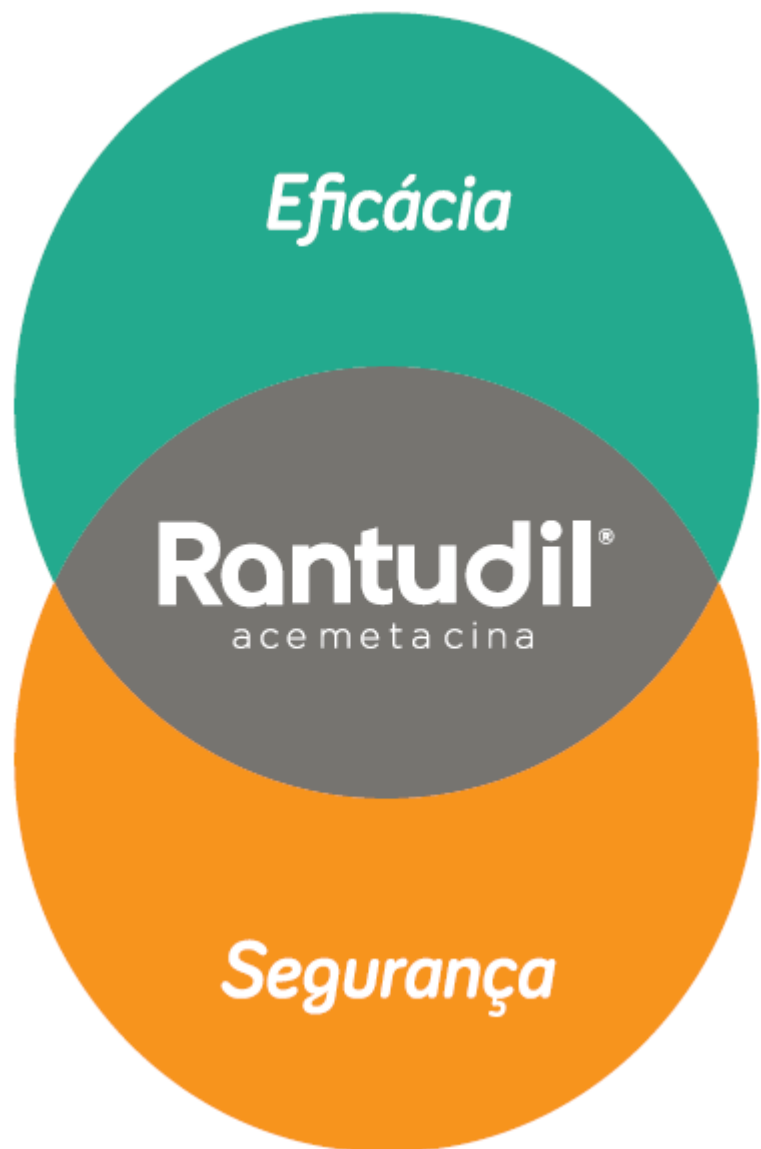




o melhor de dois mundos

DIFERENÇAS CLINICAMENTE RELEVANTES

Evento | DD/MM/202x
Palestrante

Especialidade médica

emaildopalestrante@gmail.com

AGENDA

1. AINE's

1. O que são e para que servem?
2. Eficácia
3. Segurança

2. Rantudil®

3. Reumon

1. AINE's

O que são anti-inflamatórios não esteróides?

Para que servem?

1.1 | O que são AINE's?

Os Anti-Inflamatórios Não Esteróides (AINE's) são medicamentos que tratam a dor e ajudam a controlar a inflamação. Ou seja, são fármacos com efeito anti-inflamatório, analgésico e antipirético.

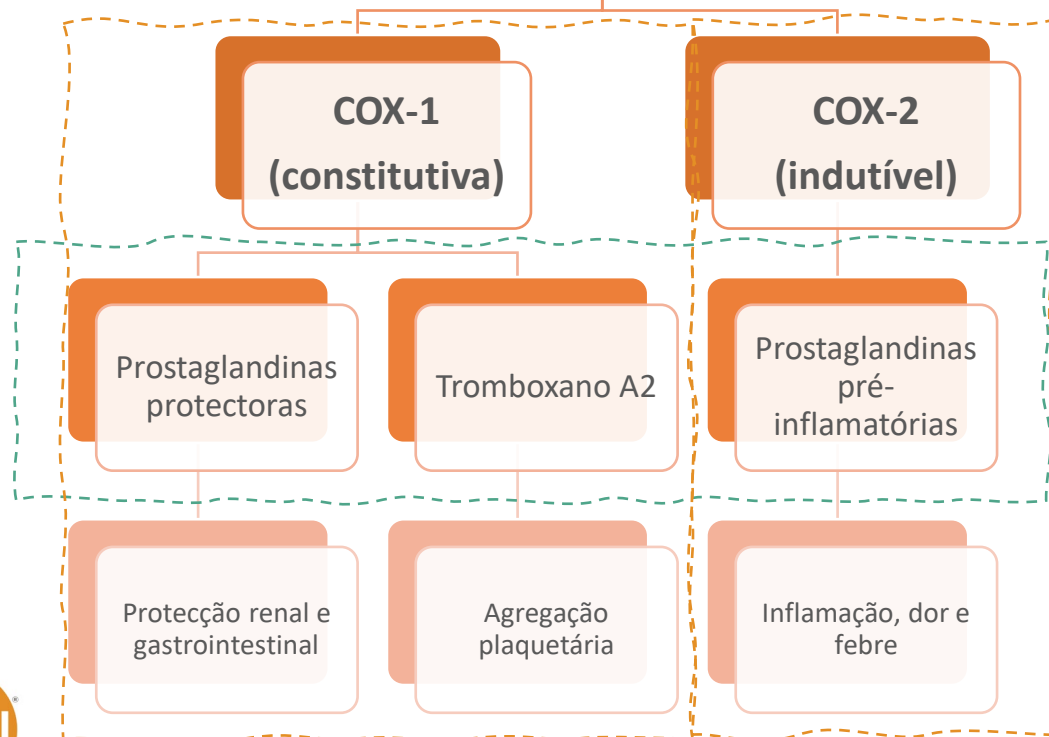
Os AINE's têm diversos efeitos adversos.

Na selecção do AINE a prescrever, interessa **escolher aquele** que **minimiza o risco desses efeitos adversos.**

O processo inflamatório



ÁCIDO
ARAQUIDÓNICO



O processo inflamatório começa com um **ESTÍMULO** que activa a **FOSFOLIPASE A2**. Esta enzima vai degradar a **MEMBRANA CELULAR** e libertar o **ÁCIDO ARAQUIDÓNICO**.

O **ÁCIDO ARAQUIDÓNICO** sofre a acção da **COX-1** e **COX-2** e dá origem a substâncias características da inflamação.

A **COX-1** é uma enzima constitutiva que tem um papel especialmente importante na protecção da mucosa gástrica.

A **COX-2** é uma enzima de expressão indutível, sendo um agente importante na progressão da resposta inflamatória. A sua inibição impede que este processo inflamatório se desenrole, ajudando a diminuir a inflamação, dor e febre.

O grande desafio da terapêutica anti-inflamatória é conseguir reduzir a dor e a inflamação sem aumentar o risco de lesão gastrointestinal.

1.2 | Eficácia nos AINE's orais

Os AINE orais não têm diferenças significativas em termos de potência analgésica (avaliado em períodos de uso inferior a 6 meses).

Li M, et al. BMJ Open. 2020 Sep 10;10(9):e036748. 8

Do ponto de vista de eficácia, os AINE's orais são igualmente eficazes e não se distinguem.

1.3 | Segurança nos AINE's

1. Risco Cardiovascular
2. Risco Gastrointestinal
3. Risco Renal
4. Risco Hepatobiliar

PERCEPÇÕES

*“A prescrição de AINE está
alicerçada em percepções...”*



1.3.1 | AINE e Risco Cardiovascular



O risco cardiovascular é semelhante entre AINE's: todos aumentam este risco que, por sua vez, aumenta com o uso quer a curto, quer a longo prazo.

- Os AINE estão associados ao **aumento do risco** de Enfarte Agudo do Miocárdio, Acidente Vascular Cerebral e Insuficiência Cardíaca.
- **Não podemos considerar os COXIBS mais seguros do que os AINE clássicos**, uma vez que os efeitos adversos cardiovasculares dos AINE não advêm da selectividade para a COX-2.
- **Não há evidência** que corrobore a percepção do naproxeno ser o AINE com maior segurança cardiovascular.

Cardiovascular Safety of Celecoxib, Naproxen, or Ibuprofen for Arthritis

Steven E. Nissen, M.D., Neville D. Yeomans, M.D., Daniel H. Solomon, M.D., M.P.H., Thomas F. Lüscher, M.D., Peter Libby, M.D., M. Elaine Husni, M.D., David Y. Graham, M.D., Jeffrey S. Borer, M.D., Lisa M. Wosniowski, R.N., Katherine E. Wolski, M.P.H., Qiaojing Wang, M.S., Venu Menon, M.D., Frank Ruschitzka, M.D., Michael Gaffney, Ph.D., Bruce Beckerman, M.D., Manuela F. Berger, M.D., Weihang Bao, Ph.D., and A. Michael Lincoff, M.D., for the PRECISION Trial Investigators*

ABSTRACT

BACKGROUND

The cardiovascular safety of celecoxib, as compared with nonselective nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), remains uncertain.

METHODS

Patients who required NSAIDs for osteoarthritis or rheumatoid arthritis and were at increased cardiovascular risk were randomly assigned to receive celecoxib, ibuprofen, or naproxen. The goal of the trial was to assess the noninferiority of celecoxib with regard to the primary composite outcome of cardiovascular death (including hemorrhagic death), nonfatal myocardial infarction, or nonfatal stroke. Noninferiority required a hazard ratio of 1.12 or lower, as well as an upper 97.5% confidence limit of 1.33 or lower in the intention-to-treat population and of 1.40 or lower in the on-treatment population. Gastrointestinal and renal outcomes were also adjudicated.

RESULTS

A total of 24,081 patients were randomly assigned to the celecoxib group (mean [±SD] daily dose, 209±57 mg), the naproxen group (852±103 mg), or the ibuprofen group (2045±246 mg) for a mean treatment duration of 20.3±16.0 months and a mean follow-up period of 34.1±13.4 months. During the trial, 68.8% of the patients stopped taking the study drug, and 27.4% of the patients discontinued follow-up. In the intention-to-treat analyses, a primary outcome event occurred in 188 patients in the celecoxib group (2.3%), 201 patients in the naproxen group (2.5%), and 218 patients in the ibuprofen group (2.7%) (hazard ratio for celecoxib vs. naproxen, 0.93; 95% confidence interval [CI], 0.76 to 1.13; hazard ratio for celecoxib vs. ibuprofen, 0.85; 95% CI, 0.70 to 1.04; P=0.001 for noninferiority in both comparisons). In the on-treatment analysis, a primary outcome event occurred in 134 patients in the celecoxib group (1.7%), 144 patients in the naproxen group (1.8%), and 155 patients in the ibuprofen group (1.9%) (hazard ratio for celecoxib vs. naproxen, 0.90; 95% CI, 0.71 to 1.15; hazard ratio for celecoxib vs. ibuprofen, 0.81; 95% CI, 0.65 to 1.02; P=0.001 for noninferiority in both comparisons). The risk of gastrointestinal events was significantly lower with celecoxib than with naproxen (P=0.01) or ibuprofen (P=0.002); the risk of renal events was significantly lower with celecoxib than with ibuprofen (P=0.004) but was not significantly lower with celecoxib than with naproxen (P=0.19).

CONCLUSIONS

At moderate doses, celecoxib was found to be noninferior to ibuprofen or naproxen with regard to cardiovascular safety. (Funded by Pfizer; ClinicalTrials.gov number, NCT00646216).

From the Cleveland Clinic, Cleveland (S.E.N., M.E.H., L.M.W., K.E.W., Q.W., V.M., A.M.L.); Western Sydney University, Campbelltown, NSW, Australia (N.D.Y.); Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston (D.H.S., P.L.); University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland (T.F.L., F.R.); Baylor College of Medicine, Veterans Affairs Medical Center, Houston (D.Y.G.); and State University of New York, Downstate Health Sciences Center (J.S.B.) and Pfizer (M.G., B.B., M.E.H., W.B.), New York. Address reprint requests to Dr. Nissen at Cleveland Clinic, J2230, 9500 Euclid Ave., Cleveland, OH 44195, or at nissen@ccf.org.

*A complete list of the committee, study centers, and investigators participating in the Prospective Randomized Evaluation of Celecoxib Integrated Safety Versus Ibuprofen or Naproxen (PRECISION) trial is provided in the Supplementary Appendix, available at NEJM.org.

This article was published on November 13, 2016, and last updated on December 2, 2016, at NEJM.org.

N Engl J Med 2016;375:2519-29.

DOI: 10.1056/NEJMoa1611559

Copyright © 2016 Massachusetts Medical Society.

2519

N ENGL J MED 375:26 DECEMBER 29, 2016

NEW ORLEANS, LA DECEMBER 28, 2016

2520

© 2016 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the publisher.

Risco Cardiovascular



A mais recente evidência mostra que **o risco cardiovascular entre AINE é muito semelhante, não se podendo diferenciar, com significado clínico, o risco cardiovascular de celecoxib, ibuprofeno, naproxeno ou diclofenac.**^{4,5}

Bial
Keeping life
in mind.

RESEARCH

OPEN ACCESS

Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian meta-analysis of individual patient data

Michèle Bally,^{1,2} Nandini Dendukuri,^{3,4} Benjamin Rich,⁴ Lyne Nadeau,⁴ Arja Helin-Salmivaara,⁵ Edeltraut Garbe,⁶ James M Brophy^{2,4,7}

¹Department of Pharmacy and Research Centre, Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, Montreal, H2K 1M4, Canada

²Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, McGill University, Montreal, Canada

³Technology Assessment Unit of the McGill University Health Centre, Montreal, Canada

⁴Division of Clinical Epidemiology, McGill University Health Centre—Research Institute, Montreal, Canada

⁵Unit of Primary Care, Hospital District of Helsinki and Uusmaa, Helsinki, Finland

⁶Department of Clinical Epidemiology, Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology—IPS, Bremen, Germany

⁷Department of Medicine, McGill University, Montreal, Canada

Correspondence to: M Bally, michele.bally@umontreal.ca

© 2016

Additional material is published online only. To view please visit the journal online.

Cite this as: BMJ 2017;357:g1909

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g1909

Accepted: 10 April 2017

WHAT IS ALREADY KNOWN ON THIS TOPIC

Evidence suggests that both traditional and cyclo-oxygenase-2 selective non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can increase the risk of acute myocardial infarction. The timing of the risk, the effect of dose, treatment duration, and the comparative risks between NSAIDs are poorly understood.

WHAT THIS STUDY ADDS

Using a bayesian meta-analysis of individual patient data and studying real world settings, it is shown that all traditional NSAIDs, including naproxen, appear to be associated with an increased risk of acute myocardial infarction. The risk with celecoxib does not seem to be greater than that with traditional NSAIDs. Onset of risk occurs in the first week. Short term use for 8–30 days at a high daily dose (celecoxib >200 mg, diclofenac >100 mg, ibuprofen >1200 mg, and naproxen >750 mg) is associated with the greatest harms, without obvious further increases in risk beyond the first 30 days.

The BMJ | BMJ 2017;357:g1909 | doi:10.1136/bmj.g1909

BMJ: first published as 10.1136/bmj.g1909 on 9 May 2017. Downloaded from http://www.bmj.com/ on 15 January 2019 by guest. Protected by copyright.

1.3.2 | AINE e Risco Gastrointestinal



Os AINE causam lesão gastrointestinal por 2 mecanismos:

1. Efeito tóxico sobre a mucosa gastrointestinal;
2. Supressão sistémica da síntese de prostaglandinas, que conduz à inibição da reparação da mucosa.

- 30 a 50% dos utilizadores de AINE apresentam lesões endoscópicas, geralmente sem qualquer manifestação clínica.
- Os AINE podem induzir lesão ao longo de todo o tracto Gastrointestinal, reconhecendo-se hoje um **aumento da incidência de lesões do tracto gastrointestoinal inferior**.
- Doentes com mais de 65 anos são os que apresentam **maior risco de desenvolver lesão gastrointestinal**.

1.3.3 | AINE e Risco Renal

Os AINE inibem a produção de prostaglandinas, quer a nível tubular, quer glomerular, comprometendo a Taxa de Filtração Glomerular.



- **Múltiplas complicações renais** associadas ao consumo de AINE: lesão renal aguda, agudização da Doença Renal Crónica, glomerulonefrite, necrose papilar renal, Hipertensão arterial em relação com retenção hídrica, acidose tubular renal, Hiponatremia, Hipocalcemia.
- **Doses elevadas de AINE:**
 - maior associação com lesão renal aguda;
 - uso prolongado: aumento do risco de Doença Renal Crónica.

1.3.4 | AINE e Risco Hepatobiliar

Deve atribuir-se primazia a **AINE's com menor índice de interações medicamentosas**, que será o **AINE com menor toxicidade** e, consequentemente, com menos efeitos secundários.

 **DRUGBANK**

Base de dados:

- Online
- Gratuita



Em suma...

**Os AINE's não são
todos iguais!**



AINE's,

é importante prescrever em segurança!

Como minimizar o risco de efeitos adversos dos AINE's?

Quais as características do AINE ideal?

1. Ser um AINE pró-fármaco
2. Maior selectividade do AINE

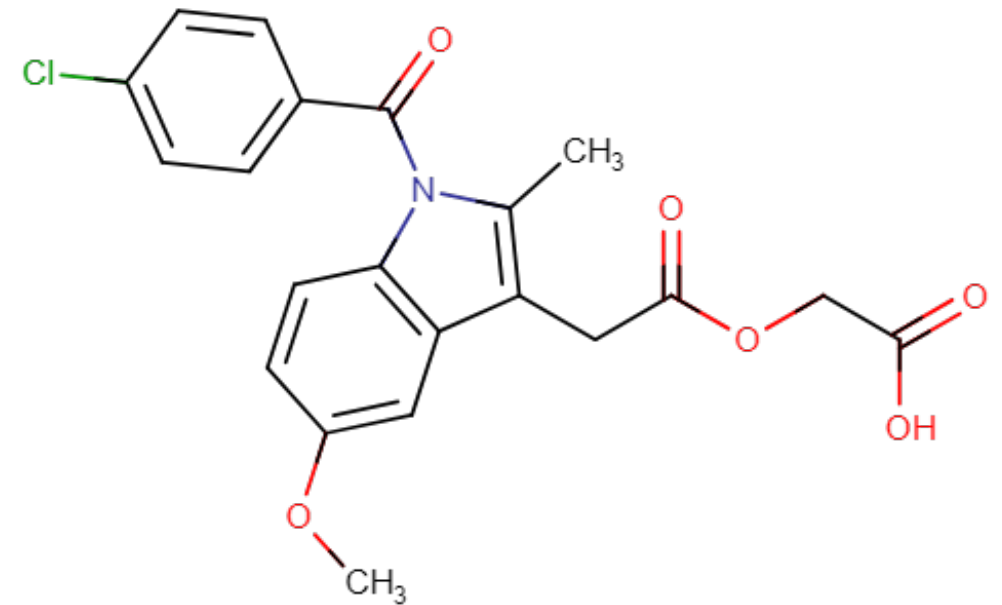
2. Rantudil®



O que é a acetmetacina?

Acemetacina é um anti-inflamatório, analgésico e antipirético, pertencente ao grupo dos derivados indólicos.

Na prática, trata-se de um **pró-fármaco de indometacina**.



O que distingue Rantudil® dos outros AINE's?

É um AINE pró-fármaco



**Melhor tolerabilidade
gastrointestinal**

Menor ligação às proteínas
plasmáticas



**Rapidez de
acção**

**Reduzida
interacção
medicamentosa**

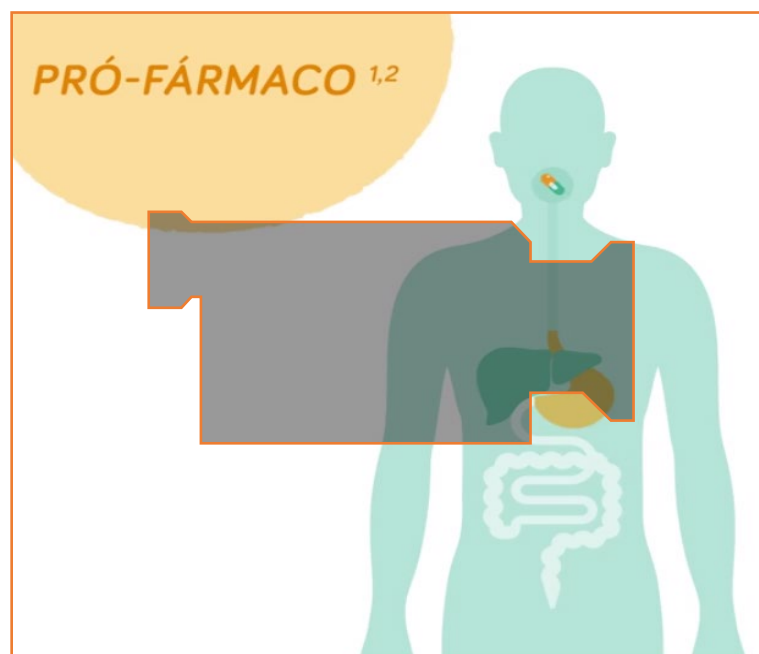
O que distingue Rantudil® dos outros AINE's?

AINE PRÓ-FÁRMACO

- O pró-fármaco está desenhado **para fazer o “bypass” ao tracto Gastrointestinal.**
- Exerce a sua acção farmacológica apenas **após 1ª passagem hepática,** contornando assim o efeito tópico dos AINE.
- Só se torna **activo quando é metabolizado.**
- O efeito de pró-fármaco traduz-se numa **menor toxicidade local.**

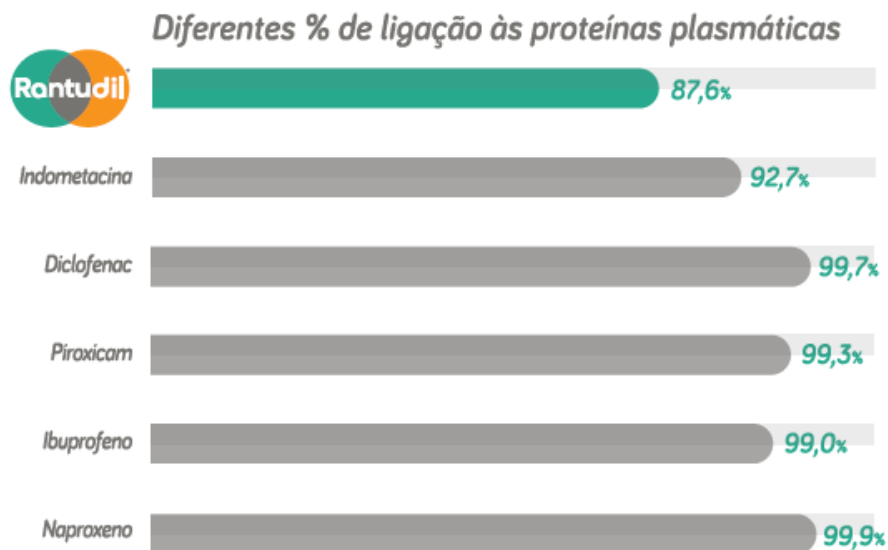
Rantudil é um pró-fármaco, pelo que beneficia de uma melhor tolerabilidade gastrointestinal.

O que distingue Rantudil® dos outros AINE's?



O que distingue Rantudil® dos outros AINE's?

MENOR LIGAÇÃO ÀS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS



A menor ligação da acetaminofeno às proteínas plasmáticas tem como vantagens:

Rapidez de acção

**Reduzida interacção
medicamentosa**

O que distingue Rantudil® dos outros AINE's?

RAPIDEZ DE ACÇÃO

A **acemetacina** é o AINE com **menor ligação às proteínas plasmáticas**. Esta característica permite que a acemetacina fique **rapidamente disponível**, e em concentrações elevadas nos tecidos inflamados, atingindo a **concentração máxima em 2 horas**.

A concentração da acemetacina:

- no líquido sinovial é **2X superior** à concentração plasmática
- na membrana sinovial é **4X superior** à concentração plasmática



Rapidez de acção

A eficácia de um fármaco é afectada pelo grau de ligação às proteínas plasmáticas. Quanto maior a fracção livre (acemetacina=12,4%), mais eficiente será a transposição das membranas celulares e a difusão.

O que distingue Rantudil® dos outros AINE's?

REDUZIDA INTERACÇÃO MEDICAMENTOSA

Farmacocinética	Acemetacina	Diclofenac	Ibuprofeno	Naproxeno	Etodolac	Etoricoxib
Índice interação	4	31	28	19	10	7



Índice de interação: probabilidade de interagir com outras moléculas.
Tabela construída a partir dos dados publicados na plataforma DrugBank

Rantudil® é a melhor opção já que apresenta o menor índice de interações medicamentosas (índice de 4 para Rantudil® vs. 31 para diclofenac e 28 para ibuprofeno) e, consequentemente, será o AINE com menor toxicidade, ie, menos efeitos secundários.



Reduzida interacção medicamentosa

A menor ligação às proteínas plasmáticas permite menos competição entre medicamentos pelo mesmo local de ligação



Em suma...

ACEMETACINA:

- Rápido início de acção
- Elevada tolerabilidade
- Reduzida interacção medicamentosa



FOCO NO DOENTE → RÁPIDO alívio da dor

A segurança de Rantudil®

EFEITOS ADVERSOS CARDIOVASCULARES

Igual em todos os AINE's

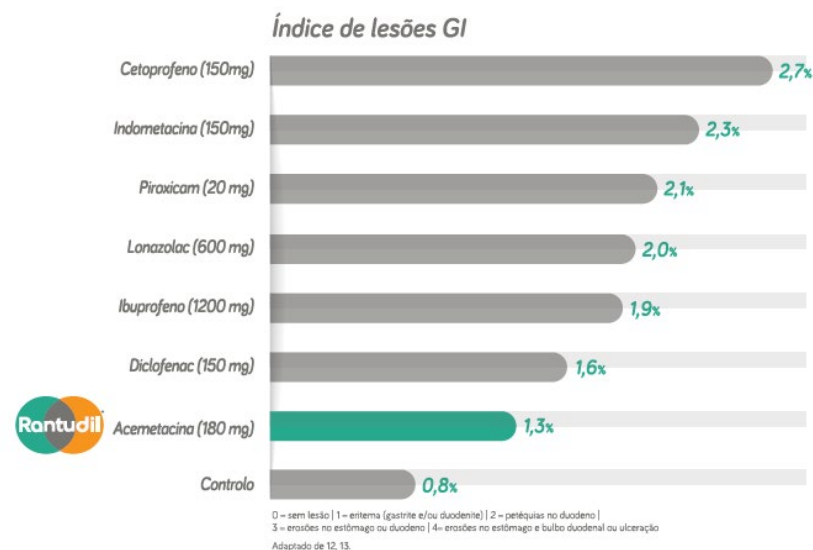
Segurança Cardiovascular



O risco cardiovascular entre AINE é muito semelhante.^{9,10}

EFEITOS ADVERSOS GASTROINTESTINAIS

Rantudil® é o mais seguro



EFEITOS ADVERSOS RENAIIS

Rantudil® é o mais seguro

Farmacocinética	Diclofenac	Ibuprofeno	 Acemetacina	Naproxeno	Etodolac
Absorção (activa)	Gástrica/duodenal	Gástrica/duodenal	Pró-fármaco	Gástrica/duodenal	Gástrica/duodenal
Ligação às Proteínas Plasmáticas	Albumina >99%	Albumina >99%	Albumina (87,6%)	Albumina >99%	Albumina >99%
Volume de distribuição	0,1-0,2L/kg	0,1L/Kg	0,5-0,7L/kg	0,39 L/kg	0,16 L/kg
Eliminação	60-70% Renal 30% Hepatobiliar	> 90% Renal < 10% Hepatobiliar	40% Renal 60% Hepatobiliar	95% Renal 5% Hepatobiliar	<73% Renal 16% Hepatobiliar

Adaptado de 16.

A segurança de Rantudil®

Rantudil® deve iniciar-se pela dosagem mais baixa (60mg) e monitorizar a função renal e hepática regularmente.¹

A farmacocinética de Rantudil® mantém-se inalterada em doentes com patologia hepática.



Individualização do tratamento

Duas formulações disponíveis – à medida do seu doente

Situações Agudas¹

Lombalgia	Entorses	Tendinites
Ciatalgia	Contusões	Bursites
Gota	Distensões	Tenossinovites

60 mg

Uma cápsula
2 a 3x /dia



Rantudil 60
acetaminofeno
60 CÁPSULAS
Bial

Rantudil® 60mg ou 90mg *Retard* permite a flexibilidade de individualizar o tratamento, em cada doente, para conseguir a dose mínima eficaz.

Situações Crónicas²

Osteoartrose
Artrite Reumatóide
Artrite Psoriática
Espondilite Anquilosante

90 mg

Uma cápsula
1 a 2x /dia



Rantudil 90 Retard
90 mg cápsulas de libertação prolongada
ACETAMINOFENO
Bial

Posologia simples

- **Rantudil® 60:** a dose média usual para os adultos é de 60 mg, 2 a 3 vezes ao dia.
- **Rantudil® 90 Retard:** a dose média usual para os adultos é de uma cápsula de libertação prolongada, 1 a 2 vezes por dia.



Rantudil® vs outros AINE

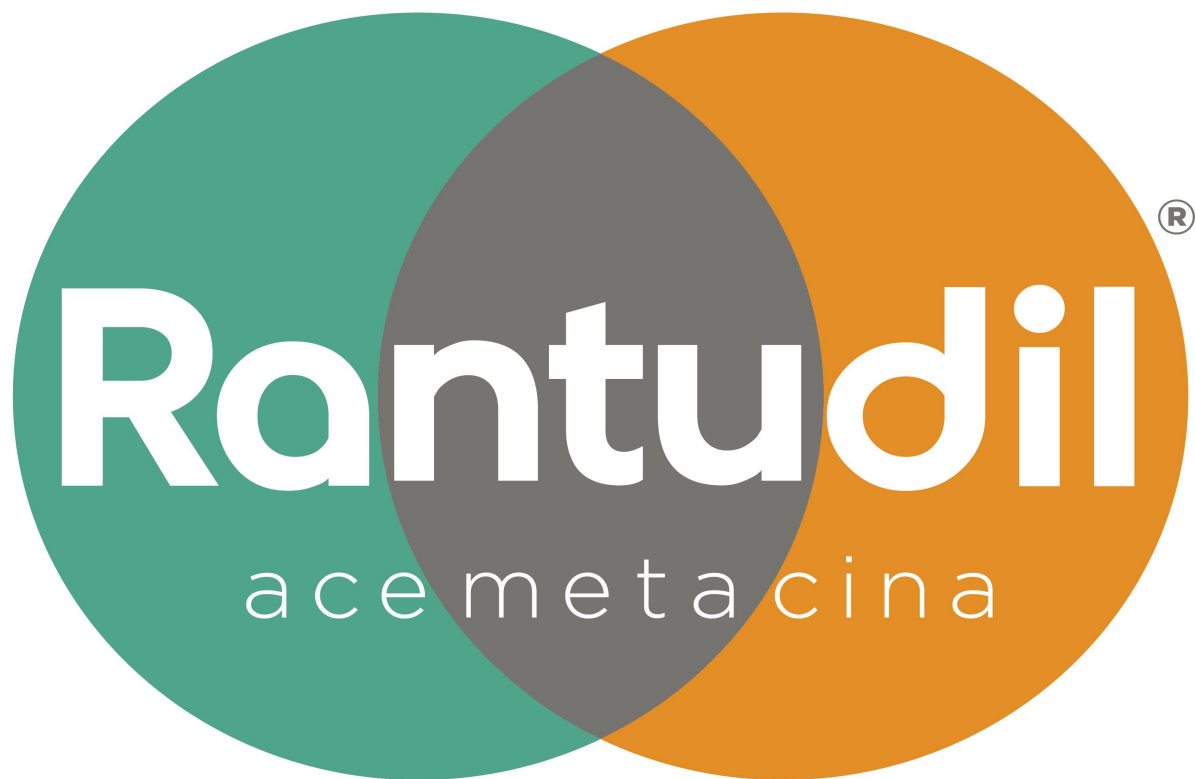
Farmacocinética	Acemetacina	Diclofenac	Ibuprofeno	Naproxeno	Etodolac	Etoricoxib	
Absorção	Gástrica pro-fármaco	Gástrica/ duodenal	Gástrica/ duodenal	Gástrica/ duodenal	Gástrica/ duodenal	Gástrica/ duodenal	<u>Rantudil</u> é um pró-fármaco , o que significa um menor efeito sobre a mucosa gástrica.
Distribuição	Albumina 87,6%	Albumina >99,7%	Albumina >99%	Albumina >99%	Albumina >99%	Albumina 92%	<u>Rantudil</u> é o AINE com menor ligação à albumina , logo: fica mais rapidamente disponível e atinge a concentração máxima em 2 horas.
Volume Distribuição	0,5-0,7 L/kg	0,1-0,2 L/kg	0,1 L/kg	0,16 L/kg	0,39 L/kg	0,12 L/kg	<u>Rantudil</u> tem elevado volume de distribuição, o que permite uma maior concentração de princípio activo nos tecidos .
Metabolismo	Fase II Glucoronoc conjugação	Fase I e II	Fase I e II	Fase I e II	Fase I e II	Fase I e II	<u>Rantudil</u> não sofre acção de enzimas do grupo CYP 450, evitando a competição com a maior parte das moléculas .
Índice interação	4	31	28	19	10	7	<u>Rantudil</u> tem baixo risco de interacção com outros fármacos .
Semi-Vida	4,5h	2h	1,2-2h	12-17h	7,3±4h	22h	A reduzida semi-vida de <u>Rantudil</u> significa estar pouco tempo em circulação , minorando probabilidade de efeitos tóxicos no organismo.
Eliminação	Renal 40% Fecal 60%	Renal 60-70% Fecal 30%	Renal 90% Fecal 10%	Renal 95% Fecal 5%	Renal >73% Fecal 16%	Renal 80% Fecal 20%	<u>Rantudil</u> tem uma menor excreção renal, o que diminui a probabilidade de lesão renal .

Pela sua farmacocinética, **Rantudil®** é o **AINE de eleição**.



Rantudil® vs outros AINE

	AINE's orais	Rantudil®
Mecanismo de acção	Variável	Inibidor preferencial da COX-2
Eficácia	✓	✓
Rapidez	Variável	Atinge concentração máxima ao fim de 2 horas.
Pró-fármaco	✗	✓
Risco Cardiovascular	✓	✓
Risco Gastrointestinal	✓	É o que apresenta menor risco. Índice mais baixo de lesões pépticas e menores perdas hemáticas.
Risco Renal	✓ Eliminação renal > 60%.	É o que apresenta menor risco. Eliminação renal = 40%.
Risco Hepatobiliar	✓	É o que apresenta menor risco.
Interacções Medicamentosas	Risco moderado a elevado	Menos interacções. Menor ligação às proteínas plasmáticas e pró-fármaco.



Tem um
leque de
indicações
mais
abrangente
do que os
outros AINE's

Eficácia

Rantudil®
acetaminofeno

Segurança

o melhor de dois mundos

Reumon®

etofenamato



O QUE É REUMON?

Anti-inflamatório de aplicação tópica
indicado em situações dolorosas
localizadas do aparelho locomotor.



INDICAÇÕES

Nevralgias

Artropatias

Mialgias

Contusões,
entorses,
distensões

Bursites,
tenossinovites

UMA OPÇÃO PARA CADA NECESSIDADE



Reumon®
etofenamato

FORMULAÇÃO EM GEL COM EFEITO REFRESCANTE ¹⁵



- Efeito refrescante – adjuvante no alívio da dor;
- Aplicação fácil quando há sensibilidade ao toque.

Quando recomendar?

- Sem necessidade de imobilização;
- Doente activo (que procura eficácia e rapidez de aplicação);
- Secagem rápida adaptada ao dia-a-dia (desporto, actividade profissional intensa...).

FORMULAÇÃO EM CREME COM EFEITO HIDRATANTE ¹⁶



- Efeito hidratante - ideal para pele seca e sensível;
- Proporciona um tratamento da dor aliado ao conforto da pele.

Quando recomendar?

- Necessidade de imobilização (ligadura/meia elástica...);
- Necessidade de massagem;
- Em contexto de fisioterapia ou tratamento prolongado.

REUMON é o tratamento tópico adjuvante que
melhora a recuperação



Reumon®
etofenamate

Eficácia

Rantudil[®]
acetaminofeno

Segurança

o melhor de dois mundos

Reumon[®]
etofenamato

PARA
UMA VIDA
COM MAIS
MOVIMENTO





Inspired by the future

RANTUDIL, cápsulas contendo 60 mg de Acemetacina; **RANTUDIL 90 Retard**, cápsulas de libertação prolongada, contendo 90 mg de Acemetacina. **Indicações terapêuticas:** Tratamento sintomático de situações dolorosas/inflamatórias agudas ou crônicas e de agudizações de patologia crônica, nomeadamente: artrite reumatóide, espondilartrites seronegativas; tendinites, tenossinovites, bursites; crises agudas de gota, lumbago, ciática; osteoartrose; situações traumáticas: distensões, entorses, contusões. **Posologia e modo de administração:** **RANTUDIL 60 mg**, 2 a 3 vezes ao dia. Nas crises agudas de gota a dose inicial pode ser de 120 mg, seguida de 60 mg de 8/8 horas. O tratamento com doses superiores a 180 mg não deve exceder os 7 dias. **RANTUDIL 90 Retard** - uma cápsula 1 a 2 vezes por dia. As cápsulas devem ser ingeridas inteiras, com um pouco de líquido, de preferência após ingestão de algum alimento. Não se recomenda o uso de RANTUDIL em crianças e adolescentes com idade inferior a 14 anos. Em doentes com disfunção renal e hepática ligeira a moderada a dose inicial deve ser reduzida. Não se deve administrar acemetacina a doentes com insuficiência renal e/ou hepática grave. **Contraindicações:** Hipersensibilidade à acemetacina ou a qualquer um dos excipientes. História de hemorragia gastrointestinal ou perfuração, relacionada com terapêutica anterior com AINE. Úlcera péptica/hemorragia ativa ou história de úlcera péptica/hemorragia recorrente (dois ou mais episódios distintos de ulceração ou hemorragia comprovada). Insuficiência hepática, renal ou cardíaca grave. Doentes em que as crises de asma, urticária ou rinite aguda sejam precipitadas pelo ácido acetilsalicílico ou por outros AINE. Doentes com hemorragia cerebrovascular ou outras hemorragias ativas. Doentes com alterações inexplicadas da hematopoiese ou sistema de coagulação. Último trimestre de gravidez. **Efeitos indesejáveis:** As reações adversas listadas por frequência (*muito frequentes: $\geq 1/10$, frequentes: $\geq 1/100$ a $< 1/10$, pouco frequentes: $\geq 1/1.000$ a $< 1/100$, raros: $\geq 1/10.000$ a $< 1/1.000$, muito raros: $< 1/10.000$, desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis)*) foram as seguintes: *Doenças do sistema nervoso:* Raros - cefaleias, vertigens, alterações transitórias da capacidade visual e auditiva. *Doenças gastrointestinais:* Os eventos adversos mais frequentemente observados são de natureza gastrointestinal. Podem ocorrer, em particular nos idosos, úlceras pépticas, perfuração ou hemorragia gastrointestinal potencialmente fatais. Náuseas, dispepsia, vômitos, hematemese, flatulência, dor abdominal, diarreia, obstipação, melenas, estomatite aftosa, exacerbação de colite ou doença de Crohn têm sido notificados na sequência da administração destes medicamentos. Menos frequentemente têm vindo a ser observados casos de gastrite. *Afeções hepatobiliares:* Elevação ocasional dos parâmetros laboratoriais da função hepática. Muito raramente: Sintomas de colestase. *Cardiopatias:* Têm sido notificados casos de edema, hipertensão e insuficiência cardíaca durante o tratamento com AINE. Os dados dos ensaios clínicos e epidemiológicos sugerem que a administração de alguns AINE (particularmente em doses elevadas e em tratamento de longa duração) poderá estar associada a um pequeno aumento do risco de eventos trombóticos arteriais (por exemplo enfarte do miocárdio e AVC). *Doenças do sangue e do sistema linfático:* Raramente, trombocitopenia, leucopenia e diminuição dos níveis de hemoglobina. Muito raramente: agranulocitose reversível e depressão da medula óssea. *Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos:* Muito raro: Reações bolhosas incluindo síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica. *Afeções oculares/afeções do ouvido e do labirinto:* Pouco frequente: tinnitus, visão turva, dor ocular. **Data da revisão do texto:** 03/2017. **Apresentação:** RANTUDIL 60 mg, cápsulas - cx.60; RANTUDIL 90 Retard: 90 mg, cápsulas, cx. 60. **Comparticipação:** Portugal - 37% (RG); 52% (RE). **Medicamento sujeito a receita médica.**

Consultar o RCM completo para informação detalhada. Para mais informações relacionadas com o medicamento e questões médicas contactar a Secção de Assuntos Médicos de BIAL - Portela & Cª., S.A: Tel.: +351 229866100. Em caso de suspeita de um acontecimento adverso ou de outra informação de segurança, contactar o Gabinete de Farmacovigilância de BIAL - Portela & Cª., S.A: Tel.: +351 229866100, email: farmacovigilancia@bial.com.

Titular da AIM: BIAL – Portela & Cª, S.A - À Av. da Siderurgia Nacional • 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugal • NIPC 500220913
DDVSAM180323

REUMON Loção, etofenamato 100 mg/ml de emulsão cutânea; **REUMON Gel**, etofenamato 50 mg/g de gel; **REUMON Creme**, etofenamato 100 mg/g de creme. **Indicações terapêuticas:** REUMON está indicado em situações dolorosas do aparelho locomotor, desde que a sintomatologia seja localizada, tais como: artropatias (periartrite, artrite, poliartrite, espondilose, osteoartrose); mialgias; bursites; tenossinovites; fibrosites; nevralgias (síndrome cervical, lombalgias, ciatalgias); contusões, entorses, distensões (associadas, por exemplo, a traumatismos desportivos). **Posologia e modo de administração:** REUMON deve aplicar-se 3-4 vezes ao dia, massajando-se suavemente sobre a zona afectada. A quantidade a aplicar varia de acordo com a extensão afetada. A duração do tratamento é variável com a situação clínica a tratar. No caso de doenças reumáticas, o tratamento durante 3 a 4 semanas é normalmente suficiente. A duração do tratamento nos traumatismos agudos (por exemplo, associados à prática de desporto) pode prolongar-se até às 2 semanas. Não utilizar em grávidas, crianças e insuficientes renais, uma vez que a experiência clínica não é suficiente. **Contraindicações:** alergia ao etofenamato ou ao ácido flufenâmico, ou a qualquer um dos excipientes de REUMON. A sua utilização está contraindicada em doentes que tiveram reacções de hipersensibilidade, tais como sintomas de asma, rinite alérgica ou urticária, ao ácido acetilsalicílico ou a outros anti-inflamatórios não esteroides; em superfícies eczematosas ou feridas abertas; nas mucosas ou nos olhos; em grávidas, crianças ou insuficientes renais, uma vez que a experiência clínica não é suficiente. **Efeitos indesejáveis:** Em aproximadamente 5% dos utilizadores de REUMON pode observar-se rubor cutâneo e em 2% podem desenvolver-se reacções alérgicas cutâneas (prurido, eritema, erupção, edema). Reacções bolhosas incluindo síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica (muito raro).

Para mais informações deverá contactar o titular da AIM: BIAL – Portela & C^a, S.A. - À Av. da Siderurgia Nacional - 4745-457 S. Mamede do Coronado – Portugal • NIPC 500220913 • Medicamento não sujeito a receita médica. Não participado. DMgMA_PT201001